

PÉRDIDA AGUDA DE LA VISIÓN

Carlos Plaza Laguardia, Marta Cuesta Lasso, Álvaro Rodríguez Castelblanco.

INTRODUCCIÓN

La pérdida de visión puede ser transitoria (si la visión se recupera en 24 horas, habitualmente menos de 1 hora) o duradera (si la pérdida se mantiene más allá de las 24 horas). A su vez, la pérdida aguda de la visión (PAV) hace referencia a su velocidad de instauración en pocos minutos u horas.

El diagnóstico diferencial de las PAV es amplio por lo que la anamnesis y la exploración física deben realizarse de manera cuidadosamente detallada, incluyendo en todo caso toma de agudeza visual, biomicroscopía del polo anterior del ojo y valoración funduscópica. Una correcta historia clínica puede acotar la sospecha diagnóstica, especialmente teniendo en cuenta los tiempos tanto de instauración como de duración de la pérdida visual. De esta manera, las causas más frecuentes de PAV se podrían clasificar en:

- Pérdidas transitorias (< 24 horas): amaurosis fugax, papiledema, aura migrañosa, neuropatía óptica isquémica y glaucoma por cierre angular. Dentro de otras causas menos frecuentes se incluye la oclusión intermitente de vena central de la retina, lesiones del sistema nervioso central u orbitario y arteritis de células gigantes.
- Pérdidas duraderas (> 24 horas): hemorragia vítrea, oclusión de una arteria o vena retiniana, desprendimiento de retina, degeneración macular asociada a la edad exudativa y neuritis óptica. Dentro de otras causas menos frecuentes encontramos el envenenamiento con metanol, otras enfermedades de la retina y la oclusión de la arteria oftálmica.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Salvo que la causa de la PAV sea evidente y de causa no oftalmológica (p. ej. migraña), la derivación del paciente al oftalmólogo debe ser la norma.

Amaurosis fugax

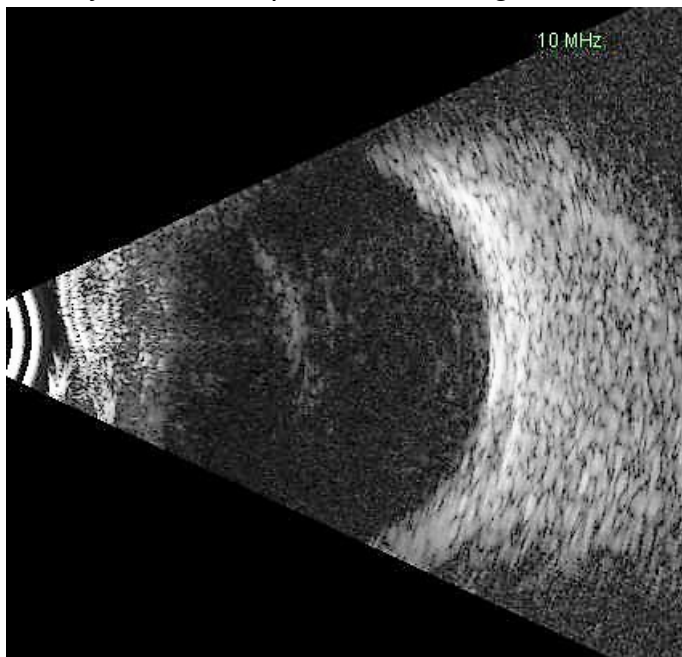
- Anamnesis: PAV unilateral de segundos o minutos de duración con recuperación completa. Puede prolongarse incluso una hora.
- Exploración: Con frecuencia la exploración oftalmológica es normal. En ocasiones se visualiza un émbolo ocluyendo una arteriola retiniana. El paciente puede presentar síntomas o signos neurológicos de un accidente isquémico transitorio acompañante.
- Es imprescindible obtener una analítica general que incluya hemograma, glucosa, perfil lipídico, PCR y VSG para descartar arteritis de células gigantes.
- Además de la auscultación cardíaca y carotídea, debe realizarse una evaluación por imagen de la perfusión de la arteria carótida (ECO Doppler dúplex).
- Tratamiento: Considerar tratamiento con ácido acetil salicílico y control de factores de riesgo cardiovascular. Cuando se diagnostique una enfermedad carotídea el paciente debe ser valorado por cirugía vascular o por cardiología si se detecta una cardiopatía.

Hemorragia vítrea

- Anamnesis: PAV unilateral. El paciente, con frecuencia diabético, suele referir visión de puntos o telarañas que progresan rápidamente hacia la PAV completa.
- Exploración: El reflejo del fondo de ojo suele estar disminuido o ausente. Si la hemorragia es severa puede haber defecto pupilar aferente relativo (DPAR). Una ecografía ocular permite

descartar patología retiniana como desprendimiento o presencia de masas.

- Tratamiento: Reposo en cama con el cabecero elevado, suspender terapia antiagregante o anticoagulante si es posible y valoración por el oftalmólogo.



Es necesario realizar una ecografía ocular cuando se diagnostica un hemovítreo con reflejo de fondo de ojo abolido.

Desprendimiento de retina

- Anamnesis: Típicamente el paciente refiere visualización de una cortina o sombra que se mueve en el campo visual con frecuencia precedido de miodesopsias y fotopsias.
- Exploración: Observación directa del desprendimiento con o sin rotura retiniana mediante funduscopia. Otros hallazgos posibles incluirían hemorragia vítrea, desprendimiento de vítreo posterior asociado o DPAR.
- Tratamiento: Aquellos pacientes que presenten un desprendimiento de retina traccional sin afectación macular (buena agudeza visual) deben realizar reposo en cama hasta la realización de la opción terapéutica elegida: retinopexia neumática, crioterapia, fotocoagulación láser o vitrectomía.
- Si existe afectación macular debe ser reparado en los 7 – 10 días siguientes al comienzo del cuadro y si el origen del desprendimiento de retina es exudativo requiere tratamiento de la patología de base.

Oclusión de una arteria retiniana

- Anamnesis: PAV unilateral indolora secundaria a la isquemia de la retina implicada.
- Si la oclusión se produce en la arteria central de la retina (OACR) todo el campo visual estará afectado, mientras que la oclusión de una rama arterial manifestará un escotoma en el campo visual correspondiente con el tejido retiniano isquémico (p. ej. la oclusión de la rama temporal superior de la retina provoca un escotoma altitudinal inferior.).
- Exploración: Aspecto pálido de la retina isquémica. Puede observarse una mancha de color rojo cereza a nivel foveal y un DPAR intenso en OACR. En ocasiones se aprecian los émbolos arteriolares.
- De manera inmediata se realizará un estudio que incluya: VSG, PCR, hemograma, bioquímica, tensión arterial, estudio carotídeo y cardiológico.

- Tratamiento: Sin haber demostrado eficacia en estudios, existen ciertas maniobras para tratar de revertir la isquemia en OACR: masaje ocular, paracentesis de cámara anterior, reducción de la presión intraocular (p. ej. acetazolamida oral, hipotensores tópicos...) o la provocación de acidosis respiratoria mediante la hiperventilación con una bolsa para lograr vasodilatación.
- El paciente debe ser derivado a un internista para un estudio completo.

Oclusión de una vena retiniana

- Anamnesis: PAV del territorio circundante correspondiente a la oclusión venosa retiniana o difusa en oclusiones de vena central de la retina (OVCR).
- Exploración: Hemorragias retinianas con tortuosidad y dilatación venosa, exudados algodonosos o edema de retina. En la OVCR estos hallazgos afectan a toda la retina y se puede encontrar edema de papila, vasos colaterales optociliares o signos de neovascularización retiniana.
- Suspender los fármacos que favorezcan la hemoconcentración o la trombosis (p. ej.: anticonceptivos, diuréticos...), reducir la presión intraocular si esta elevada y tratamiento de las causas médicas subyacentes (p. ej.: factores de riesgo cardiovascular, hipercoagulabilidad...).
- Tratamiento: No existen ensayos que demuestren su eficacia, sin embargo, en ocasiones se recomienda comenzar tratamiento con ácido acetil salicílico.

Papiledema (edema papilar por aumento de la presión intracraneal)

- Anamnesis: PAV intermitente de segundos de duración frecuentemente bilateral acompañada de cefalea y vómitos.
- Exploración: Papilas ópticas edematosas y de coloración rojiza. Puede haber hemorragias en llama papilares y peripapilares, DPAR, dilatación venosa y defectos campimétricos.
- El estudio inicial del papiledema debe incluir una prueba de imagen, preferiblemente una resonancia magnética (RM) urgente con gadolinio y una flebografía por RM (si no se dispone de RM resonancia, se puede realizar un TC).
- Tratamiento: Debe ir dirigido a tratar la causa subyacente de hipertensión intracraneal.

Migraña con aura visual

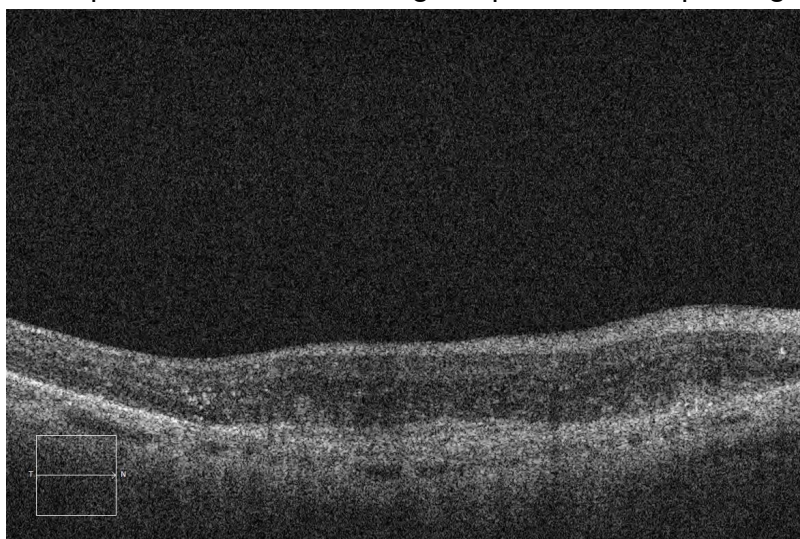
- Anamnesis: Los síntomas visuales que en ocasiones preceden a la migraña se denominan aura. El aura se instaura de manera aguda y puede incluir destellos, visión borrosa y escotomas positivos y negativos. Se mantiene durante unos 15 a 30 minutos y precede a la cefalea, que característicamente suele ser pulsátil, unilateral y acompañada de sensación nauseosa y fotofobia.
- Exploración: No suelen existir signos patológicos asociados.
- Tratamiento: Evitar factores desencadenantes: alcohol, estrés, anticonceptivos orales, etc...
- Derivar a un neurólogo o internista para el tratamiento farmacológico escalonado. Suelen emplearse antiinflamatorios no esteroideos, considerando terapias más potentes (triptanes o los derivados ergotamínicos) si los anteriores fracasan.

Glaucoma de ángulo cerrado

- Anamnesis: Visión borrosa asociada a dolor, cefalea, náuseas y vómitos.
- Exploración: La presión intraocular estará elevada por el cierre del ángulo iridocorneal, la córnea edematosa suele presentar edema epitelial y la pupila en midriasis media arreactiva.
- Tratamiento: (ver capítulo: Glaucoma agudo de ángulo cerrado)

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa

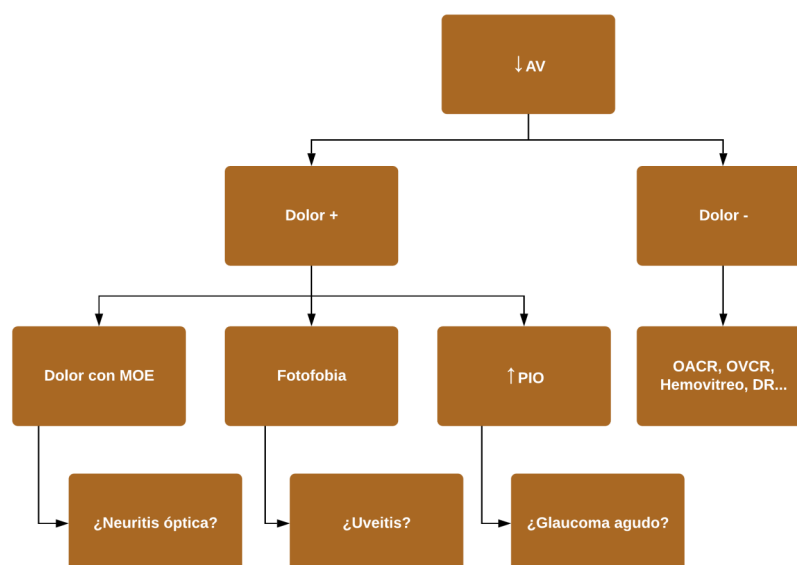
- Anamnesis: La PAV central se instaura de forma rápidamente progresiva y se acompaña de metamorfopsia. La DMAE seca provoca PAV de instauración lenta.
- Exploración: Drusas (pequeños depósitos amarillentos), hemorragias, exudación o membranas neovasculares en el fondo de ojo (coloración grisácea).
- Tratamiento: Derivación preferente al oftalmólogo especialista en patología macular.



Pacientes con DMAE con actividad recurrente pueden presentar PAV en relación al aumento de grosor de su retina.

Neuritis

- Anamnesis: PAV que empeora a lo largo de los días. Asocia dolor que aumenta con los movimientos oculares (MOE) y alteración de la percepción de los colores (discromatopsia) y de la intensidad lumínica. Sospechar debut de esclerosis múltiple (EM) en paciente joven.
- Exploración: Defectos campimétricos de predominio central o altitudinal, DPAR y tumefacción de la papila en neuritis anterior. Precisa una exploración neurológica completa, toma de la presión arterial y otras determinaciones de laboratorio si se considera necesario: títulos de Lyme, VSG, ECA, FTA – ABS, RPR, además de RM con gadolinio de encéfalo y órbita.
- Tratamiento: Varía en función de los hallazgos de la RM y debe ser instaurado por el neurólogo pudiendo iniciarse bolos de metilprednisolona 1 g/día i.v. durante 3 días en caso de sospecha de EM. Este tratamiento con corticoesteroides sólo aumenta la rapidez de la recuperación visual, sin afectar al resultado final.



De manera esquemática se resumen las causas más frecuentes de disminución aguda de agudeza visual junto a sus hallazgos más característicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Gerstenblith AT, Rabinowitz MP. The wills eye manual: office and emergency room diagnosis and treatment of eye disease. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- Kanski JJ, Bowling B. Oftalmología clínica. 7ª Edición, Mosby Barcelona 1996.
- Optic Neuritis Study Group. The 5-year risk of MS after optic neuritis. Experience of the optic neuritis treatment trial. Neurology 1997; 49(5): 1404.